

COMMUNICATION

SBAR + R = SBAR₂

S Situation	▶ Degré d'urgence ▶ Identité du patient et âge ▶ Motif d'hospitalisation ▶ Attitude thérapeutique ▶ Objectif médical du jour	C'est Aline du JUL-22. Je t'appelle pour M. ZZ, 64 ans, qui a des vertiges depuis 5 min. Il est là pour une pneumonie et diabète décompensé ; il est IMU-2. Les endocrinologues doivent passer aujourd'hui.
B Background	▶ Antécédents, allergies	Il est aussi connu pour une hypertension.
A Appréciation	▶ Examen clinique réalisé ▶ Signes vitaux modifiés ▶ Évaluation du problème du jour du patient	Il a une tension à 105/65 (d'habitude 140/80), avec un pouls irrégulier à 55/min, sat 93% AA. La glycémie est à 15.8 mmol/l. Il est un peu mieux allongé.
R Recommandation ou requête	▶ Ce qu'il reste à faire	J'aimerais que tu viennes l'évaluer d'ici 30 minutes. Veux-tu un ECG ?
R Reformulation (par le receveur)	▶ Résume ce qui a été dit ▶ Pose des questions ▶ Redit l'essentiel à faire	Donc, un patient de 64 ans qui présente des vertiges, avec une hypotension nouvelle. Oui, volontiers pour un ECG. J'arrive dans 5 min.

- Stratégie pour communiquer des informations importantes ou critiques
- Permet d'informer tous les membres de l'équipe simultanément
- Aide les autres membres à anticiper les prochaines étapes
- Important pour identifier la personne responsable d'une tâche donnée

Exemple :

Leader: *Voies aériennes?*

Médecin: *Voies aériennes libres*

Leader: *Ventilation?*

Médecin: *Ventilation diminuée à droite*

Leader: *Tension?*

Infirmière: *Tension 96/62*

La communication en boucle fermée est utilisée pour s'assurer que l'information donnée a été comprise de la manière souhaitée.

3 étapes:

- 1 Message émis
- 2 Receveur accepte le message
- 3 Confirmation du message émis

Exemple :

Médecin : *On va lui donner 40 mg de Lasix iv*

Infirmière : *Lasix 40mg iv*

Médecin : *Oui, c'est bien ça*

LEADERSHIP

Capacité de maximiser les activités des membres, en s'assurant que les actions de chacun et chacune soient comprises, que l'information soit partagée, et que tout le monde dispose des ressources nécessaires.

Compétences d'un leader efficace Brief, huddle et debrief

- Définit le plan, l'assigne, le fait connaître, en surveille l'exécution et le modifie
- Vérifie la performance de l'équipe
- Etablit des "règles de conduite"
- Identifie et articule des objectifs clairs
- Délègue les tâches et les responsabilités
- Donne un feedback concernant les tâches confiées et la progression vers le but à atteindre
- Gère les ressources
- Facilite le partage d'informations
- Encourage les membres de l'équipe à s'entraider
- Facilite la résolution de conflits

Partager le plan

Brief: courte séance avant de débiter, permettant de répartir les rôles et responsabilités, d'établir les attentes, et préciser les objectifs

Monitorer et adapter le plan

Concertation ou caucus (huddle): synthèse "ad hoc" pour mettre à jour l'équipe, renforcer les plans en cours et évaluer le besoin d'adapter le plan

Revoir la performance

Debrief: séance d'échange informel pour améliorer la performance et l'efficacité d'équipe, renforcement des éléments positifs

MONITORAGE DE LA SITUATION

Surveillance active de la situation pour s'informer et comprendre ce qui se déroule, et rester attentif pour soutenir l'équipe.

OUTIL	UTILISATION
STEP	Statut du patient ou de la patiente
I'M SAFE	Etat des membres de l'équipe
Cross-monitoring	Etat de l'environnement et des autres membres
STAR	Etat d'activité de tâches spécifiques

STEP I'M SAFE (checklist) Cross-monitoring STAR

1. Statut du patient ou de la patiente:

Anamnèse
Signes vitaux
Médicaments
Examen physique
Plan de soins
Etat psychique

2. Team (membres):

Fatigue
Charge de travail
Performance (tâches)
Compétences
Stress

3. Environnement:

Administration
Ressources humaines
Pertinence du triage
Equipe

4. Progrès vers le but:

Faire un huddle
Statut des patients et patientes à charge
Objectifs de l'équipe
Tâches/actions faites ou à faire
Plan toujours approprié ?



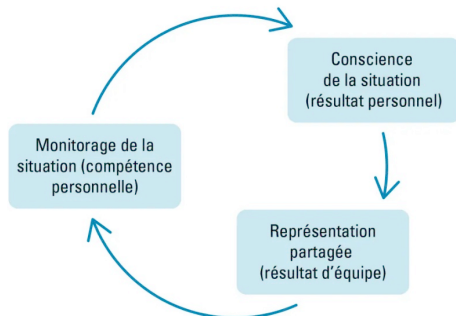
Chaque membre de l'équipe se doit une évaluation par rapport à :

- ✓ **I** = Illness
- ✓ **M** = Médicaments
- ✓ **S** = Stress
- ✓ **A** = Alcool et drogues
- ✓ **F** = Fatigue
- ✓ **E** = Elimination et alimentation

Une stratégie pour réduire les erreurs:

- Monitoring des actions des autres membres de l'équipe
- Soutien et surveillance au sein de l'équipe
- Permet d'éviter des erreurs, ou de les identifier de façon précoce
- "Watching each other's back"

Le monitoring est un processus continu d'observation et d'évaluation de ce qui se passe autour de soi.



- **STOP**: s'arrêter pour se refocaliser sur la tâche actuelle
- **THINK**: penser méthodiquement et identifier la bonne action
- **ACT**: agir
- **REVIEW**: confirmer que le résultat attendu s'est produit ou changer de stratégie

SOUTIEN MUTUEL

- Prévoir le feed-back et **définir les objectifs** (si possible avant)
- Demander une **auto-évaluation** (points forts, points à améliorer)
- Donner un **feed-back basé sur la description des faits**, équilibrer les points forts et ceux à améliorer
- **Vérifier la compréhension** du feed-back
- Trouver ensemble des **moyens pour progresser**

Avocat du patient ou de la patiente (patient partenaire)

Représenter l'opinion du patient et de la patiente est important, surtout lorsque les membres de l'équipe sont en désaccord.

Déclaration affirmée

Se manifester de façon **ferme** et **respectueuse** pour:

- Exprimer son inquiétude
- Enoncer le problème (réel ou perçu)
- Offrir une solution
- Trouver un accord

Permet à tous les membres de l'équipe de s'opposer à l'action, voir l'arrêter ("stop the line"), s'ils perçoivent un problème qui pourrait mettre en danger le patient ou la patiente.

Lorsque vous vous manifestez une première fois, et que rien ne se passe:

- Il est de votre responsabilité de vous manifester au moins à 2 reprises pour être sûr d'avoir été entendu
- Le membre de l'équipe concerné doit montrer qu'il vous a entendu
- Si votre inquiétude n'a pas été résolue, persévérez, ou adressez-vous à un ou une supérieure

Un outil pour guider la formulation d'un "challenge"

Je suis en **S**ouci parce que !...

Je suis **M**al à l'aise parce que !...

Ceci concerne la **S**écurité du patient !

Une approche constructive pour la résolution des conflits.

D Décrire la situation ou le comportement,
avec des données concrètes

E Exprimer les sentiments/soucis
engendrés par cette situation

S Suggérer des alternatives et chercher
un accord

C Conséquences à énoncer en terme de
l'impact sur les objectifs d'équipe déjà
établis ; viser un Consensus